

**LAMPIRAN KETENTUAN KHUSUS
MANULIFE CRITICAL CARE PROTECTION**

Lampiran Ketentuan Khusus **Manulife Critical Care Protection** ("Lampiran Ketentuan Khusus") ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dan tidak mempunyai hak atas pembagian laba Penanggung (distribusi surplus).

**PASAL 1
DAFTAR PENYAKIT KRITIS**

A. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Autoimun

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
1	Insufisiensi Adrenal Kronis (Penyakit Addison) Penyakit Addison (atau penyakit Addison, adrenalitis autoimun) adalah insufisiensi adrenokortikal akibat kerusakan atau disfungsi seluruh korteks adrenal. Diagnosis tegas dikonfirmasi oleh ahli endokrin. Diagnosis penyakit Addison (atau penyakit Addison, adrenalitis autoimun) harus didukung oleh semua ketentuan berikut ini: 1. Terjadi peningkatan ACTH darah lebih dari 50 pg/ml; dan 2. Tidak ada bukti peningkatan aldosteron (kortison serum) dengan tes ACTH; dan 3. Dibutuhkan terapi penggantian glukokortikoid dan mineral kortikoid seumur hidup. Hanya penyebab autoimun dari insufisiensi adrenal primer yang dipertanggungjawabkan dalam Pertanggungan ini. Semua penyebab lain dari insufisiensi adrenal dikecualikan.		
2	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>) Kelainan pada beberapa sistem, disebabkan oleh banyak faktor, gangguan kekebalan sendiri (<i>autoimun</i>) yang ditandai dengan adanya auto-antibodi terhadap beberapa <i>self-antigen</i>. Dalam konteks ini, terbatas hanya pada bentuk <i>systemic lupus erythematosus</i> yang menyerang ginjal (Kelas III sampai Kelas VI) dibuktikan dengan biopsi ginjal dan sesuai dengan klasifikasi Organisasi	1	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan (<i>Mild Systemic Lupus Erythematosus</i>) Lupus eritematosus sistemik adalah kelainan pada beberapa sistem, disebabkan oleh banyak faktor dan terdapat gangguan kekebalan sendiri (<i>autoimun</i>) yang ditandai dengan adanya auto-antibodi terhadap beberapa <i>self-antigen</i>. Lupus eritematosus sistemik ringan akan dibatasi untuk bentuk-bentuk yang membutuhkan terapi sistemik

	Kesehatan Dunia (WHO) atau yang menyerang sistem saraf pusat. Klasifikasi WHO untuk lupus: Kelas I: Minimal perubahan <i>glomerulonefritis</i> Kelas II: <i>Glomerulonefritis Mesangial</i> Kelas III: <i>Focal Segmental glomerulonefritis</i> Kelas IV: <i>Diffuse glomerulonefritis</i> Kelas V: Glomerulonefritis membranosa. Lupus sistem saraf pusat mempunyai gejala kejang dengan defisit neurologis permanen yang dibuktikan dengan ketidakmampuan untuk melakukan 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari tanpa bantuan. Diagnosis akhir harus dibuat oleh Dokter Spesialis rematologi dan imunologi. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Systemic Lupus Erythematosus</i>: <i>Discoïd</i> lupus dan kondisi lupus yang menyerang darah atau sendi.	imunosupresif yang melibatkan banyak organ selama minimal 6 (enam) bulan di bawah arahan Dokter Spesialis. Bukti harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis yang merawat dan dapat dibuktikan bahwa telah melibatkan setidaknya tiga organ tertentu. Untuk keperluan manfaat ini, organ tertentu yang dimaksud adalah ginjal, otak, jantung (atau perikardium), paru-paru (atau pleura) dan sendi. Sendi didefinisikan sebagai adanya arthritis inflamasi <i>polyarticular</i>. Diagnosis akhir harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis reumatologi dan imunologi. Keterlibatan kulit tidak dianggap sebagai salah satu organ tertentu untuk tujuan manfaat ini. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Lupus Erimatosus Sistemik Ringan: 1. Kulit sebagai organ; atau 2. Lupus erimatosus sistemik bentuk lain, <i>discoïd</i> lupus dan yang menyerang darah.
3	<i>Rheumatoid Arthritis Berat (Severe Rheumatoid Arthritis)</i> <i>Rheumatoid arthritis</i> kronis sebagai akibat gangguan autoimun yang didiagnosis oleh Dokter Spesialis <i>rheumatology</i> dan <i>immunology</i>. Karakteristik dari Penyakit ini adalah harus memenuhi semua kriteria sebagai berikut: 1. Berdasarkan diagnosis dari <i>American College of Rheumatology</i>, dan 2. Kerusakan dan kelainan bentuk paling sedikit 3 (tiga) dari sendi-sendi berikut sendi tangan interphalangeal, sendi pergelangan tangan, siku, lutut, persendian pinggul, pergelangan kaki, tulang leher atau sendi kaki interphalangeal. Semua gejala yang timbul harus ditegakkan dengan pemeriksaan klinis dan studi Imaging yang memperlihatkan adanya perubahan tersebut; dan 3. Ketidakmampuan fisik menyebabkan ketidakmampuan melakukan 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud	2 <i>Rheumatoid Arthritis Progresif Ringan</i> <i>Rheumatoid arthritis</i> progresif ringan sebagai akibat gangguan autoimun yang didiagnosis oleh Dokter Spesialis <i>rheumatology</i> dan <i>immunology</i>. Karakteristik dari Penyakit ini adalah harus memenuhi semua kriteria sebagai berikut: 1. Berdasarkan diagnosis dari <i>American College of Rheumatology</i>, dan 2. Kerusakan dan kelainan bentuk paling sedikit 3 (tiga) dari sendi-sendi berikut sendi tangan interphalangeal, sendi pergelangan tangan, siku, lutut, persendian pinggul, pergelangan kaki, tulang leher atau sendi kaki interphalangeal. Semua gejala yang timbul harus ditegakkan dengan pemeriksaan klinis dan studi Imaging yang memperlihatkan adanya perubahan tersebut; dan 3. Ketidakmampuan fisik menyebabkan ketidakmampuan

	pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus. Kondisi tersebut harus berlangsung selama periode minimal 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak didiagnosis rheumatoid arthritis berat oleh seorang Dokter Spesialis.		melakukan 2 (dua) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus; dan Kondisi tersebut harus berlangsung selama periode minimal 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak didiagnosis <i>rheumatoid arthritis</i> progresif ringan oleh seorang Dokter Spesialis.
4	Skleroderma Progresif Penyakit kolagen-vaskular sistemik menyebabkan fibrosis progresif menyeluruh pada kulit, pembuluh darah dan organ <i>visceral</i> . Diagnosis harus didukung oleh biopsi, bukti serologi, dan gangguan tersebut harus secara sistemik meliputi jantung, paru-paru atau ginjal. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Skleroderma Progresif: 1. Skleroderma lokal (linear skleroderma atau <i>morfea</i>); atau 2. <i>Eosinophilic fasciitis</i> ; atau 3. Sindrom CREST.	3	Skleroderma Progresif Tahap Awal Dokter Spesialis rheumatologist harus menegaskan diagnosis pasti dari skleroderma sistemik progresif, berdasarkan pada kriteria klinik dan diagnosis ini harus didukung oleh biopsi dan bukti serologi. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Skleroderma Progresif Tahap Awal: 1. Skleroderma lokal (skleroderma linear atau <i>morphea</i>); atau 2. <i>Eosinophilic fasciitis</i> ; atau 3. Sindrom CREST.

B. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Ginjal

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
5	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>) Kegagalan kronik kedua ginjal yang menetap (<i>irreversible</i>) yang memerlukan cuci darah yang terus menerus atau transplantasi ginjal.	4	Gagal Ginjal Tahap Awal (<i>Early Kidney Failure</i>) Diagnosis gagal ginjal kronis yang menunjukkan gangguan fungsi ginjal permanen dan harus ditegakkan oleh seorang Dokter Spesialis ginjal dan didukung oleh hasil laboratorium yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal di mana eGFR kurang dari 30ml/menit/1.73m ² luas permukaan tubuh selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih.
6	Kista-kista pada Ginjal bagian Medula (<i>Medullary Kidney Cystic Disease</i>) Penyakit ginjal karena faktor keturunan yang ditandai oleh hilangnya fungsi ginjal secara bertahap dan bertambah berat karena kista dalam medula ginjal. Diagnosis harus didukung oleh bukti pindai (<i>imaging</i>) yang menunjukkan adanya kista medula multiple dengan pengecilan korteks.		
7	<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i> <i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>	5	Neuropati Perifer Neuropati Perifer mengacu pada

	harus memenuhi kriteria: 1. Edema akibat kehilangan protein ginjal 2. Hipoalbuminemia <25g/l 3. Proteinuria > 150 mg/m²/jam (> 3,6g/m²/hari) 4. 4 (empat) kali atau lebih kekambuhan dari sindrom nefrotik berat yang didefinisikan di atas (sebagaimana didefinisikan dalam 1 sampai 3) yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah episode awal sindrom nefrotik berat yang memerlukan pengobatan terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan.	neuropati motorik perifer berat yang timbul dari sel tanduk anterior yang mengakibatkan kelemahan motorik yang signifikan, fasikulasi dan pengecilan otot. Diagnosis harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis saraf sebagai hasil dari pemeriksaan konduksi saraf yang hasilnya menunjukkan kebutuhan permanen untuk penggunaan alat bantu berjalan atau kursi roda. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Neuropati Perifer: Neuropati diabetik dan neuropati karena alkohol.
		6 Operasi Pengangkatan Satu Ginjal Operasi pengangkatan lengkap 1 (satu) ginjal yang diharuskan akibat Penyakit atau Kecelakaan. Keperluan untuk operasi pengangkatan ginjal harus dibuktikan untuk harus benar-benar diperlukan oleh Dokter internis. Donasi ginjal dikecualikan.

C. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Hati

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
8	Atresia Bilier Atresia bilier/<i>biliary atresia</i> (BA) adalah penyakit progresif, idiopatik, fibro-obliteratif dari pohon bilier ekstra-hepatik yang muncul dengan obstruksi bilier dan telah menjalani transplantasi hati atau terdaftar dalam daftar tunggu (<i>waiting list</i>) transplantasi hati. Diagnosis ini harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis pencernaan/gastroenterologi dengan bukti pendukung termasuk <i>imaging</i>, tes laboratorium dan biopsi hati. Atresia Bilier karena penyakit lain dikecualikan.	7	Bedah Rekonstruksi Saluran Empedu (<i>Biliary Tract Reconstruction Surgery</i>) Tindakan bedah rekonstruksi saluran empedu yang melibatkan <i>choledchoenterostomy</i> (<i>choledchojejunostomy</i> atau <i>choledochoduodenostomy</i>) untuk pengobatan Penyakit saluran empedu, termasuk atresia bilier, yang tidak dapat dilakukan tindakan bedah atau endoskopi lainnya. Prosedur ini harus dianggap sebagai pengobatan yang paling tepat oleh Dokter Spesialis Penyakit hepatobilier. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Bedah Rekonstruksi Saluran Empedu: Bedah rekonstruksi saluran empedu akibat Penyakit batu empedu atau kolangitis.
9	Hepatitis Autoimun Kronis Gangguan hati <i>necro-inflammatory</i> kronis dengan penyebab yang tidak diketahui terkait dengan antibodi otomatis yang bersirkulasi dan kadar serum globulin yang		

	tinggi. Diagnosis harus didasarkan pada semua kriteria berikut: 1. Hiper-gammaglobulinaemia; dan 2. Adanya setidaknya satu dari auto-antibodi berikut: i. Antibodi Anti Nuklir; ii. Antibodi Otot Polos; iii. Antibodi Anti-Aktin; iv. Antibodi Anti-Lkm-1; 3. Konfirmasi biopsi hati dari Diagnosis hepatitis autoimun. Pertanggung jawaban ini hanya berlaku jika Tertanggung dirawat dengan terapi immunosupresif selama 6 (enam) bulan atau didokumentasikan berada di bawah Dokter Spesialis pencernaan/gastroenterologi atau hepatologi selama 6 (enam) bulan.		
		8	Hepatitis B atau Hepatitis C yang Didapatkan Melalui Pekerjaan Infeksi virus Hepatitis B atau C yang didapatkan dari Kecelakaan yang terjadi setelah Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum akibat seleksi risiko terkini atau tanggal penerbitan Pemulihan Pertanggung jawaban yang terkini, mana yang paling akhir, selama Tertanggung melaksanakan tanggung jawab profesi yang normal dari pekerjaannya di Indonesia dengan mengikuti bukti dan ketentuan yang berlaku di Penanggung sebagai berikut: 1. Infeksi hepatitis B atau hepatitis C yang timbul harus dilaporkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Kecelakaan terjadi; dan 2. Bukti bahwa Kecelakaan akibat pekerjaan Tertanggung tersebut adalah penyebab pasti timbulnya infeksi hepatitis B atau hepatitis C dan melibatkan sumber pasti dari hepatitis B atau cairan C terinfeksi; dan 3. Memerlukan terapi antivirus sebagai konsekuensi terbukti terinfeksi; dan 4. Infeksi hepatitis B atau hepatitis C yang disebabkan oleh penyebab lain termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan seksual dan

		penggunaan obat intravena dikecualikan dari Penyakit ini. Manfaat Pertanggungungan ini hanya dapat dibayarkan ketika pekerjaan Tertanggung adalah seorang praktisi medis, <i>housemen</i>, mahasiswa kedokteran, perawat negara terdaftar, teknisi laboratorium medis, dokter gigi (dokter bedah gigi dan perawat gigi) atau pekerja paramedis yang bekerja di pusat kesehatan atau klinik (di Indonesia). Penanggung tidak bertanggung jawab jika terdapat kegagalan dalam mengamati praktik prosedural atau pekerjaan sesuai ketentuan yang diperlukan pada praktik vaksinasi.
10	Hepatitis Virus yang Berat (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>) Kematian jaringan luas pada hati yang disebabkan oleh virus dan mengakibatkan kegagalan fungsi hati. Kriteria diagnosis yang harus dipenuhi: 1. Pengecilan ukuran hati yang terjadi dengan cepat; 2. Kematian jaringan mengenai seluruh lobus (bagian) hati, hanya tersisa jaringan retikular (rangka) hati yang kolaps; 3. Gangguan yang cepat pada hasil pemeriksaan fungsi hati; 4. Penyakit Kuning (<i>jaundice</i>); dan 5. Tanda-tanda obyektif ensefalopati portasistemik (gangguan fungsi otak akibat gangguan pembuluh darah hati). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Hepatitis Virus yang Berat (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>): Keadaan yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh percobaan bunuh diri atau keracunan atau overdosis obat atau konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan.	
		9 Hepatitis dengan Sirosis Adanya kematian jaringan di dalam hati yang disebabkan oleh virus hepatitis yang menyebabkan terjadinya sirosis. Diagnosis pasti dari sirosis hati harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis

		pencernaan/<i>gastroenterology</i> yang dibuktikan dengan hasil biopsi hati menunjukkan histologi tahap F4 oleh penilaian Metavir atau skor fibrosis Knodell = 4 (empat). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Hepatitis Dengan Sirosis: Penyakit hati sekunder terhadap alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
11	Penyakit Hati Stadium Akhir (<i>End Stage Liver Disease</i>) Kegagalan fungsi hati stadium akhir yang bersifat permanen dan menetap (<i>irreversible</i>) dan ditandai dengan penyakit kuning (<i>jaundice</i>) yang bersifat permanen, cairan dalam rongga perut (<i>ascites</i>), dan degenerasi otak (<i>encephalopathy</i>). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit Hati Stadium Akhir (<i>End Stage Liver Disease</i>): Penyakit hati karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau mengonsumsi minuman mengandung alkohol.	10 <i>Primary Sclerosing Cholangitis</i> Kronis Klaim yang diajukan harus memenuhi seluruh ketentuan berikut: 1. Diagnosis <i>primary sclerosing cholangitis</i> kronis dikonfirmasi dengan <i>cholangiogram imaging</i> yang menunjukkan obliterasi progresif dari saluran empedu; dan 2. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis penyakit dalam atau Dokter Spesialis pencernaan/gastroenterologi atau yang terkait di bidangnya; dan 3. Kondisi medis Tertanggung harus sudah berkembang ke tahap di mana terjadi Penyakit kuning permanen; dan 4. Tertanggung sudah memerlukan terapi <i>imunosupresif</i>, obat untuk <i>intactable pruritus</i> atau jika obliterasi saluran empedu sudah membutuhkan <i>dilatasi</i> dengan balon atau pemasangan stent pada saluran empedu. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Primary Sclerosing Cholangitis</i> Kronis: <i>Sklerosis</i> saluran empedu atau obstruksi akibat pembedahan saluran empedu, Penyakit batu empedu, infeksi, peradangan Penyakit usus atau kondisi sekunder lainnya sebagai pencetus.
		11 Operasi Hati Operasi sebagian dari hati yang mencakup setidaknya seluruh bagian dari 1 (satu) lobus hati yang diperlukan sebagai akibat dari Penyakit atau Kecelakaan. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Operasi Hati: 1. Penyakit hati sekunder yang

			disebabkan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan; atau 2. Pembedahan sebagai donor.
12	Penyakit <i>Wilson</i> Kelainan <i>Toksisitas</i> Tembaga yang berpotensi fatal, yang dicirikan oleh penyakit hati <i>progresif</i> dan/atau kemunduran neurologis karena endapan tembaga. Diagnosis Penyakit <i>Wilson</i> harus dikonfirmasi oleh seorang Dokter Spesialis Terdaftar di bidang yang relevan dan terapi menggunakan <i>chelating agent</i> harus sudah dilakukan minimal selama 6 (enam) bulan.		

D. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Infeksi

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
13	Ebola Infeksi virus Ebola di mana kondisi berikut terpenuhi: 1. Keberadaan virus Ebola telah dikonfirmasi dengan pengujian laboratorium; dan 2. Terdapat komplikasi infeksi yang terus berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya gejala.		
14	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>) Peradangan berat pada otak yang diakibatkan infeksi virus dan menyebabkan defisit neurologis menetap yang berlangsung untuk jangka waktu minimal 6 (enam) minggu dan dinyatakan oleh seorang Dokter Spesialis saraf. Defisit saraf menetap termasuk, namun tidak terbatas pada retardasi mental dan kelumpuhan. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Virus Ensefalitis: Ensefalitis sebagai akibat dari infeksi HIV.	12	Ensefalitis dengan Pemulihan Peradangan parah substansi otak (belahan otak, batang otak atau otak kecil) yang disebabkan oleh infeksi virus yang membutuhkan rawat inap minimal 14 (empat belas) hari berturut-turut. Diagnosis harus dikonfirmasi oleh seorang Dokter Spesialis saraf dan didukung dengan investigasi yang tepat untuk membuktikan infeksi virus akut otak. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Ensefalitis dengan Pemulihan: Ensefalitis yang disebabkan oleh infeksi HIV.
15	Full Blown AIDS Manifestasi klinis AIDS (<i>Acquired Immuno-deficiency Syndrome</i>) harus didukung oleh hasil tes antibodi HIV (<i>Human Immuno-deficiency Virus</i>) positif dan tes konfirmasi. Selain itu, tertanggung harus memiliki jumlah CD4 kurang dari 200 (dua ratus)/μL dan satu atau lebih kriteria berikut ini terpenuhi:		

	1. Penurunan berat badan lebih dari 10% (sepuluh persen) berat badan selama 6 (enam) bulan atau kurang (sindrom wasting); atau 2. <i>Kaposi Sarcoma</i>; atau 3. <i>Pneumocystis Carinii Pneumonia</i>; atau 4. Leukoensefalopati multifokal progresif; atau 5. Tuberkulosis Aktif; atau 6. Kurang dari 1000 (seribu) Limfosit/μL; atau 7. Limfoma ganas.		
16	HIV Karena Transplantasi Organ Infeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) melalui transplantasi organ dengan ketentuan semua kondisi berikut terpenuhi: 1. Transplantasi organ secara medis diperlukan atau diberikan sebagai bagian dari perawatan medis; dan 2. Transplantasi organ diterima di Indonesia setelah Tanggal Penerbitan, Tanggal Pengesahan atau Tanggal Pengaktifan Kembali Polis ini, mana yang lebih lama; dan Keadaan dibawah ini dikecualikan dari HIV Karena Transplantasi Organ: 1. Jika telah ditemukan obat/penyembuhan untuk AIDS/ dampak dari virus HIV/ jika pengobatan sedang dikembangkan dan disetujui yang membuat virus HIV tidak aktif dan tidak menular. 2. Infeksi HIV yang ditularkan melalui cara lain, termasuk aktivitas seksual atau penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang secara intravena.		
17	HIV Karena Kejahatan Seksual (<i>HIV Infection due to Assault</i>) Infeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang diakibatkan oleh kekerasan fisik atau seksual yang terjadi setelah Tanggal Penerbitan, tanggal pengesahan atau tanggal berlakunya kembali Polis ini, mana saja yang lebih akhir, dengan ketentuan bahwa seluruh kondisi berikut terpenuhi: 1. Insiden tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan kasus pidana harus dibuka; Dan 2. Bukti penyerangan yang menyebabkan penularan harus dilaporkan kepada Perusahaan dalam		

	waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerangan terjadi; Dan 3. Bukti bahwa penyerangan tersebut melibatkan sumber pasti dari cairan yang terinfeksi HIV; Dan 4. Bukti serokonversi dari HIV negatif menjadi HIV positif yang terjadi dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penyerangan yang terdokumentasi. Bukti ini harus mencakup tes antibodi HIV negatif yang dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari setelah penyerangan. Manfaat ini tidak berlaku jika ditemukan obat medis untuk AIDS atau efek dari virus HIV atau pengobatan medis yang dikembangkan yang menghasilkan pencegahan terjadinya AIDS.		
18	HIV yang Didapatkan Melalui Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired HIV</i>) Infeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) didapatkan dari suatu Kecelakaan akibat dari pekerjaannya yang terjadi setelah Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum akibat seleksi risiko terkini atau tanggal penerbitan Pemulihan Pertanggungjawaban yang terkini, mana yang paling akhir, selama Tertanggung melaksanakan tanggung jawab profesi yang normal dari pekerjaannya di Indonesia, dengan mengikuti semua bukti dan ketentuan yang ada di Penanggung sebagai berikut: 1. Infeksi HIV yang timbul harus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kecelakaan terjadi; dan 2. Bukti bahwa Kecelakaan akibat dari pekerjaannya tersebut adalah penyebab timbulnya infeksi HIV; dan 3. Bukti bahwa <i>sero-conversion</i> dari HIV negatif menjadi HIV positif terjadi dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal Kecelakaan terjadi. Bukti ini harus dilengkapi dengan melakukan tes antibodi HIV negatif dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal Kecelakaan akibat dari pekerjaannya. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari HIV yang Didapatkan Melalui Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired HIV</i>): 1. Infeksi HIV yang disebabkan oleh		

	penyebab lain termasuk namun tidak terbatas kegiatan seksual dan penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang secara intravena. 2. Jika telah ditemukan obat/penyembuhan untuk AIDS/ dampak dari virus HIV/ jika pengobatan sedang dikembangkan dan disetujui yang membuat virus HIV tidak aktif dan tidak menular.		
19	HIV yang Didapatkan Melalui Transfusi Darah (<i>HIV due to blood transfusion</i>) Tertanggung terinfeksi oleh <i>human immunodeficiency virus</i> (HIV) melalui transfusi darah yang memenuhi semua kondisi sebagai berikut: 1. Transfusi darah yang secara medis diperlukan dan diberikan karena merupakan bagian dari pengobatan; dan 2. Transfusi darah dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum akibat seleksi risiko terkini atau tanggal penerbitan Pemulihan Pertanggungan yang terkini, mana yang paling akhir; dan 3. Sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut; dan 4. Tertanggung bukan merupakan penderita thalassaemia major atau haemophilia. Manfaat Pertanggungan pada Pasal 1.E.16 dan Pasal 1.E.17 Daftar Penyakit Kritis Tahap Akhir pada Lampiran Ketentuan Khusus Polis ini tidak berlaku apabila sebelum terjadinya infeksi virus HIV telah dilakukan pengobatan medis untuk mengobati AIDS atau untuk mengobati dampak dari infeksi virus HIV atau telah menerima penatalaksanaan untuk mencegah terjadinya AIDS. Pengobatan yang dimaksud adalah pengobatan yang membuat virus HIV tidak aktif atau tidak menyebabkan infeksi.		
20	Meningitis Bakteri (<i>Bacterial Meningitis</i>) Radang selaput otak atau selaput saraf tulang belakang yang disebabkan oleh bakteri dan mengakibatkan gangguan neurologis permanen dan bermakna	13	Meningitis Bakteri dengan Penyembuhan (<i>Bacterial Meningitis with Recovery</i>) Infeksi bakteri yang mengakibatkan peradangan parah pada selaput otak

	paling sedikit 6 (enam) minggu setelah tanggal terdiagnosis. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis Saraf dan adanya infeksi bakteri pada cairan serebrospinal dilakukan pemeriksaan dengan cara <i>lumbar puncture</i>. Keadaan ini dikecualikan dari Meningitis Bakteri (<i>Bacterial Meningitis</i>): Jenis meningitis lainnya termasuk meningitis viral (meningitis yang disebabkan oleh virus).	atau sumsum tulang belakang yang memerlukan rawat inap minimal 14 (empat belas) hari berturut-turut. Diagnosis ini harus dibuktikan dengan: 1. Adanya infeksi bakteri dalam cairan serebrospinal yang diketahui melalui pungsi lumbal; dan 2. Seorang Dokter Spesialis saraf. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Meningitis Bakteri dengan Penyembuhan (<i>Bacterial Meningitis with Recovery</i>): 1. Meningitis bakteri dengan adanya infeksi HIV; atau 2. Semua bentuk lain dari meningitis, termasuk meningitis viral.
21	<i>Necrotizing Fasciitis</i> Terjadinya <i>Necrotizing Fasciitis</i> di mana semua kondisi berikut terpenuhi: 1. Kriteria klinis yang biasa dari <i>Necrotizing Fasciitis</i> terpenuhi; dan 2. Bakteri yang diidentifikasi merupakan penyebab <i>Necrotizing Fasciitis</i> yang diketahui; dan 3. Terjadi kerusakan otot dan jaringan lunak lain yang meluas yang mengakibatkan hilangnya fungsi secara total dan permanen dari bagian tubuh yang terkena.	
22	Penyakit <i>Creutzfeldt – Jakob</i> (Penyakit Sapi Gila) Terjadinya Penyakit <i>Creutzfeld-Jacob</i> atau Penyakit <i>Variant Creutzfeld-Jacob</i> di mana ada defisit neurologis terkait, yang bertanggung jawab penuh atas ketidakmampuan permanen untuk melakukan setidaknya 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit <i>Creutzfeldt – Jakob</i> (Penyakit Sapi Gila): Penyakit yang disebabkan oleh pengobatan hormon pertumbuhan manusia.	
23	Penyakit Kaki Gajah Kronis (<i>Elephantiasis</i>) Lesi tahap akhir dari filariasis, ditandai dengan pembengkakan masif di jaringan tubuh akibat terhambatnya sirkulasi darah atau pembuluh limfatik.	

	Diagnosis kaki gajah yang tegas haruslah: Secara klinis dikonfirmasi oleh seorang Dokter Spesialis di bidang relevan; dan Didukung oleh konfirmasi laboratorium mikrofilaria. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit Kaki Gajah Kronis (<i>Elephantiasis</i>): Limfedema yang disebabkan oleh infeksi dengan penyakit lain atau trauma atau bekas luka pasca operasi atau gagal jantung kongestif atau kelainan sistem limfatik bawaan.		
24	Polio Terjadinya polio dengan dipenuhinya kondisi berikut: 1. Disebabkan oleh virus polio; dan 2. Terjadinya kelumpuhan otot tungkai atau otot pernapasan dan sudah berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.		
25	Tuberkulosis Meningitis Tuberkulosis Meningitis mengacu pada meningitis yang terbukti disebabkan oleh <i>mycobacterium tuberculosis</i>. Defisit Neurologis Permanen harus bertahan setidaknya selama 6 (enam) minggu yang mengakibatkan salah satu dari keduanya: 1. Gangguan kognitif parah yang didokumentasikan oleh neuropsikologis standar yang mengakibatkan kebutuhan untuk pengawasan terus menerus; atau 2. Gangguan fisik yang mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk melakukan setidaknya 1 (satu) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Tuberkulosis Meningitis: Meningitis yang terjadi dengan adanya infeksi HIV.		

E. Penyakit Kritis yang Berhubungan dengan Jantung

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
26	Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner (<i>Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery</i>) Tertanggung menjalani <i>ballooning angioplasty, atherectomy</i> atau perawatan	14	<i>Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal Langsung (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting - MIDCAB)</i> <i>Coronary artery bypass grafting</i> dilakukan dengan prosedur <i>port</i>

laser untuk mengobati penyempitan (*stenosis* minimal 70% (tujuh puluh persen)) dari 2 (dua) atau lebih arteri koroner utama dengan riwayat kegiatan fisik/latihan dengan pembatasan pada *syntomatology*.

Riwayat kegiatan fisik di sini terdiri dari:

1. Gejala yang cukup berat untuk menunjukkan bahwa tingkat masa depan Tertanggung hidup toleransi latihan akan dibatasi pada tingkat minimal untuk mencegah episode lebih lanjut dari nyeri dada.
2. Pendapat Dokter Spesialis jantung yang mendefinisikan kebutuhan untuk membatasi latihan fisik sehingga dapat meminimalkan nyeri sedang sampai *angina* parah.

Bukti medis harus mencakup semua hal berikut ini:

1. Laporan lengkap dari Dokter Spesialis Penyakit jantung (*cardiologist*);
2. Bukti perubahan EKG yang signifikan dan relevan dengan gejala penyakit (depresi segmen ST sebesar 2 (dua) milimeter atau lebih); dan
3. Bukti *angiografik* yang memastikan bahwa lokasi dan tingkat *stenosis* dari 2 (dua) atau lebih arteri koroner utama.

Arteri koroner utama didefinisikan sebagai *left main stem*, *left anterior descending*, *circumflex*, dan *right coronary artery*.

Untuk Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner, maksimum jumlah Manfaat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah (mana yang lebih rendah):

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan Manfaat MiUltimate Critical Care Protection; atau
- b. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)/ USD2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dikurangi dengan total untuk Manfaat atau jenis Penyakit Kritis yang sama yang

akses (teknik *thoracoscopic*) atau prosedur MIDCAB (*bypass* arteri koroner terbuka okulasi di mana median sternotomi tidak diperlukan) untuk memperbaiki penyumbatan di arteri koroner.

Keadan dibawah ini dikecualikan dari ***Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal Langsung (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting - MIDCAB)***:

Semua prosedur intravaskular;

Ketika Penyakit Arteri Koroner Ringan atau Pembedahan Kardiovaskular telah diklaim maka tidak ada lagi manfaat untuk tindakan ***Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal Langsung (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting - MIDCAB)*** yang dapat dibayarkan.

	telah dibayarkan oleh Penanggung. Pembayaran Manfaat tersebut di atas untuk Penyakit Kritis ini hanya dilakukan 1 (satu) kali saja dan sisa dari manfaat (75% (tujuh puluh lima persen)) dari Uang Pertanggungan) yang ada untuk asuransi Penyakit Kritis lainnya mengacu kepada ketentuan Manfaat yang ada pada Ringkasan Polis.		
27	<i>Cardiomyopathy</i> Diagnosis yang telah ditegakkan oleh Dokter Spesialis jantung bahwa <i>cardiomyopathy</i> disebabkan oleh kerusakan fungsi bilik ventrikel jantung, ditunjukkan oleh hasil ECG yang tidak normal, dikonfirmasi oleh <i>echo cardiography</i>, dan menyebabkan ketidakmampuan fisik secara menetap (<i>irreversible</i>) dengan derajat paling sedikit sebagaimana yang tercantum pada Kelas IV sesuai dengan <i>New York Heart Association Classification of Cardiac Impairment</i> (NYHA). Klasifikasi NYHA Kelas IV: pasien menunjukkan gejala saat istirahat meskipun sedang dalam penggunaan obat dan penyesuaian diet. Kondisi ini dibuktikan dengan fungsi ventrikel yang abnormal pada pemeriksaan fisik dan laboratorium. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Cardiomyopathy</i>. <i>Cardiomyopathy</i> yang langsung berhubungan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol dan obat-obatan.	15	<i>Cardiomyopathy</i> Tahap Awal Diagnosis yang telah ditegakkan oleh Dokter Spesialis jantung bahwa <i>cardiomyopathy</i> disebabkan oleh kerusakan fungsi bilik ventrikel jantung, ditunjukkan oleh hasil ECG yang tidak normal, dikonfirmasi dengan pemeriksaan <i>echocardiography</i>, menyebabkan ketidakmampuan fisik secara permanen, dan tidak dapat dipulihkan (<i>irreversible</i>) sesuai dengan klasifikasi gangguan jantung kelas III dari <i>New York Heart Association</i> (NYHA). Klasifikasi Kelas III NYHA: ketidakmampuan yang bermakna ditandai dengan pasien dalam kondisi nyaman dalam posisi istirahat namun kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sangat terbatas dari biasanya dan menunjukkan gejala-gejala dari gagal jantung kongestif. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Cardiomyopathy</i> Tahap Awal: <i>Cardiomyopathy</i> yang secara langsung berhubungan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol dan obat-obatan.
28	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung Demam rematik dengan kerusakan katup jantung mengacu pada demam rematik akut di mana semua kondisi diagnostik berikut harus dipenuhi: 1. Diagnosis oleh konsultan kardiovaskular atau spesialis di bidang yang relevan yang mengkonfirmasi adanya kriteria diagnostik yang ditentukan oleh <i>American Heart Association</i> pada Tertanggung; dan 2. Inkompetensi sedang (fraksi		

	regurgitasi 30% (tiga puluh persen) atau lebih) dari setidaknya 1 (satu) katup jantung telah berkembang sebagai konsekuensi tunggal dari demam rematik, didukung oleh <i>ekokardiogram</i>. Pertanggungjawaban atas Penyakit ini akan berakhir pada saat ulang tahun Tertanggung yang ke-21 (dua puluh satu) tahun.		
29	Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>) Diartikan hipertensi primer pada arteri pulmonalis dengan pembesaran bilik jantung kanan yang bermakna yang ditunjukkan oleh pemeriksaan termasuk kateterisasi jantung, dan mengakibatkan gangguan fisik menetap paling tidak Kelas IV gangguan jantung dari <i>New York Heart Association</i> (NYHA) <i>Classification</i> dan harus memiliki tekanan Arteri Pulmonalis diatas 30mmHg selama minimal 6 (enam) bulan. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis: Penyebab sekunder hipertensi pulmonalis termasuk tetapi tidak terbatas pada Penyakit paru-paru kronis, emboli paru-paru, Penyakit katup jantung dan Penyakit jantung bagian kiri.	16	Hipertensi Pulmonalis Awal Hipertensi pulmonal primer dengan pembesaran bilik jantung kanan yang bermakna, yang dibuktikan melalui pemeriksaan termasuk kateterisasi jantung dan mengakibatkan gangguan fisik permanen dengan tingkat setidaknya dari Kelas III dari klasifikasi gangguan jantung <i>New York Heart Association</i> (NYHA). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Hipertensi Pulmonalis Awal: Penyebab sekunder dari hipertensi pulmonal, termasuk namun tidak terbatas pada Penyakit kronis paru-paru, emboli paru, Penyakit katup jantung dan Penyakit jantung bilik kiri.
30	Operasi <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Koroner (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>) Operasi <i>bypass</i> pembuluh darah koroner yang bertujuan untuk memperbaiki penyempitan atau penyumbatan pada satu atau lebih pembuluh darah koroner dengan cara <i>bypass</i>, harus ada bukti angiografi lebih dari 50% (lima puluh persen) penyumbatan pembuluh darah koroner, dan pemeriksaan tersebut harus atas pertimbangan keperluan medis oleh Dokter Spesialis jantung. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Operasi <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Koroner: Angioplasti atau pemasangan stent dan teknik kateter intra-arteri lainnya atau prosedur <i>keyhole</i> atau laser.	17	<i>Transmyocardial Laser Revascularisation</i> Tindakan pembedahan untuk pertama kalinya melalui <i>transmyocardial laser revascularisation</i> untuk mengoreksi penyempitan atau penyumbatan 1 (satu) atau lebih pembuluh jantung koroner. Semua pembedahan atau prosedur lainnya dikecualikan dari manfaat ini.
31	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Surgery to Aorta</i>) Operasi pembedahan perut atau dada	18	<i>Large Asymptomatic Aortic Aneurysm</i> Terdapat aneurisma pembuluh darah

	untuk memperbaiki aneurisma, penyempitan, penyumbatan atau penyayatan pembuluh darah aorta melalui operasi terbuka. Yang dimaksud definisi aorta ini adalah pembuluh darah aorta thoracalis (<i>thoracic aorta</i>) atau aorta abdominalis (<i>abdominal aorta</i>) namun tidak termasuk cabang-cabangnya. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Operasi Pembuluh Darah Aorta: 1. Operasi pembuluh darah aorta akibat cedera yang berasal dari luar tubuh; atau 2. Pembedahan yang dilakukan dengan cara intra arterial atau luka sayat kecil.		aorta abdominal tanpa disertai gejala atau aneurisma pembuluh darah aorta toraks atau diseksi pembuluh darah aorta yang dibuktikan dengan teknik <i>imaging</i> yang tepat. Diameter pembuluh darah aorta harus diperbesar melebihi dari 55mm (lima puluh lima millimeter) dan diagnosis harus ditegakkan oleh seorang Dokter Spesialis jantung.
		19	Pemasangan Alat Pacu Jantung (<i>Cardiac Pacemaker Insertion</i>) Pemasangan alat pacu jantung permanen diperlukan sebagai akibat dari gangguan irama jantung yang tidak dapat diobati melalui cara lain. Pemasangan alat pacu jantung ini harus atas indikasi medis dan atas anjuran Dokter Spesialis jantung.
		20	Pemasangan Defibrilator Jantung Pemasangan Defibrilator Jantung permanen akibat dari aritmia jantung yang tidak dapat diterapi dengan metode lain. Prosedur pembedahan harus atas dasar sangat diperlukan menurut Dokter Spesialis jantung.
		21	Pembedahan Sistem Kardiovaskular Tindakan pembedahan minimal invasive atau berbasis kateter untuk memperbaiki penyakit atau kelainan pada dinding jantung, katup jantung, arteri koroner (tidak termasuk prosedur Angioplasti Koroner untuk memperbaiki satu atau beberapa arteri utama yang ditunjukkan oleh bukti angiografi. Arteri Koroner mengacu pada arteri koroner utama kiri, kiri anterior descending, sirkumfleksa dan arteri koroner kanan, tetapi tidak termasuk cabang-cabangnya), aorta, atau pemulihan irama jantung. Semua pendekatan intra-arteri dan kateter lainnya yang tidak dilakukan pada arteri koroner,

			katup jantung, aorta, atau pemulihan irama jantung maka dikecualian. Aorta yang dimaksud hanya mencakup <i>thoracic aorta</i> dan <i>abdominal aorta</i> , namun tidak mencakup cabang-cabangnya.
32	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Replacement</i>) Tujuan pembedahan jantung terbuka untuk mengganti atau memperbaiki kelainan katup jantung. Bukti kelainan katup jantung dari pemeriksaan kateterisasi jantung atau ekokardiogram harus diberikan oleh dan atas persetujuan Dokter Spesialis jantung. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penggantian Katup Jantung: Pemotongan katup jantung (<i>ballon valvotomy</i>) atau teknik serupa lainnya.	22	<i>Percutaneous Valvuloplasty / Valvotomy</i> Manfaat ini dibayarkan apabila katup jantung diperbaiki atau diganti dengan balon <i>valvuloplasty</i> atau teknik <i>valvotomy</i> yang tidak melibatkan torakotomi.
33	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung Penyakit Kawasaki adalah kelainan genetik yang ditandai dengan tulang yang rapuh, osteoporosis, dan mudah patah. Tertanggung harus didiagnosis sebagai <i>Osteogenesis Imperfecta</i> tipe III yang dikonfirmasi dengan terjadi semua kondisi berikut: 1. Hasil pemeriksaan fisik Tertanggung oleh Dokter Spesialis di bidang yang relevan; 2. Hasil pemeriksaan rotgen menunjukkan adanya patah tulang ganda dan kifoskoliosis progresif; 3. Hasil positif dari biopsi kulit. Vaskulitis sistemik yang tidak diketahui asalnya yang terjadi terutama pada anak-anak. Penyakit Kawasaki dengan komplikasi jantung mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan diagnosis didasarkan pada tes darah untuk mendeteksi anemia ringan, jumlah sel darah putih di atas tingkat normal, tingkat sedimentasi eritrosit yang meningkat yang menunjukkan vasculitis (radang) pada pembuluh darah dan peningkatan tajam jumlah trombosit dan memenuhi semua kondisi berikut ini: 1. Terdapat pelebaran atau pembentukan aneurisma yang		

	menetap pada 1 (satu) atau lebih arteri koroner berdiameter sekurang-kurangnya 6 (enam) milimeter; dan 2. Diagnosis harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis anak yang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan <i>echocardiographic</i> yang menunjukkan adanya dilatasi atau pembentukan <i>aneurisma</i> pada arteri <i>coronary</i> selama minimum 6 (enam) bulan sejak diagnosis awal dan telah dilakukan tindakan pembedahan. Diagnosis harus didukung oleh ekokardiografi. Pertanggungjawaban atas Penyakit ini akan berakhir pada saat ulang tahun Tertanggung yang ke-21 (dua puluh satu) tahun.		
34	Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius (<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>) Penyempitan dari salah satu arteri koroner dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan 2 (dua) arteri koroner lainnya dengan minimal 60% (enam puluh persen) yang dibuktikan dengan coronary arteriography, tanpa memandang apakah operasi sudah dilakukan atau belum. Arteri koroner yang dimaksud adalah <i>Left Main Coronary Artery (LM)</i>, <i>Left Anterior Descending Artery (LAD)</i>, <i>Circumflex (CX) Artery</i> dan <i>Right Coronary Artery (RCA)</i>.	23	Penyakit Arteri Koroner Ringan Penyempitan lumen dua arteri koroner minimal 60% (enam puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil angiografi koroner. Akibat dari penyempitan arteri koroner tersebut adalah timbulnya gejala yang tidak dapat terkontrol menggunakan terapi medis. Salah satu dari lesi/penyempitan lumen tersebut harus sudah pernah dilakukan tindakan angioplasti arteri koroner. Arteri koroner yang dimaksud adalah <i>Left Main Coronary Artery (LM)</i>, <i>Left Anterior Descending Artery (LAD)</i>, <i>Circumflex Artery (CX)</i> dan <i>Right Coronary Artery (RCA)</i> namun tidak termasuk cabang-cabangnya. Jika klaim untuk Penyakit arteri koroner ringan ini telah disetujui maka tidak ada lagi manfaat untuk <i>Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal Langsung</i> atau angioplasti yang akan dibayarkan Penanggungjawab.
		24	Perikardiektomi Menjalani <i>pericardiectomy</i> atau setiap prosedur bedah yang memerlukan operasi jantung <i>keyhole</i> sebagai akibat dari Penyakit perikardial. Kedua prosedur bedah ini harus atas indikasi medis dan atas anjuran Dokter Spesialis Jantung.

			Keadaan di bawah ini dikecualikan dari perikardiektomi: Drainase efusi pericardial atau biopsi menggunakan jarum.
35	Serangan Jantung (<i>Heart Attack</i>) Kematian sebagian otot jantung sebagai akibat kurangnya suplai darah ke jantung. Kriteria diagnostik yang harus dipenuhi pada saat terjadinya serangan tersebut adalah harus memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (lima) kriteria berikut di mana sesuai dengan diagnosis serangan jantung pertama: 1. Adanya nyeri dada khas pada saat serangan; 2. Terjadinya perubahan-perubahan gambaran elektrokardiogram yang khas untuk <i>Infark Myocardial</i> stadium dini; 3. Terjadinya peningkatan pada kadar enzim jantung CK-MB; 4. Terjadinya peningkatan <i>cardiac troponin T</i> atau <i>I</i> 0,5ng/ml (0,5mcg/L) keatas; dan 5. <i>Left Ventricular Ejection fraction</i> kurang dari 50% (lima puluh persen) yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan atau lebih setelah serangan. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari serangan jantung: Semua sindrom koroner akut lainnya termasuk namun tidak terbatas pada <i>unstable angina</i>, <i>microinfarction</i> dan kerusakan otot jantung minimal atau peningkatan biomarker jantung atau Troponin T atau I setelah dilakukannya prosedur jantung intra-arteri termasuk namun tidak terbatas pada angiografi koroner dan angioplasti koroner.		
36	Sindrom Eisenmenger Parah Sindrom Eisenmenger adalah terjadinya pintasan alur (<i>shunt</i>) jantung yang terbalik akibat hipertensi paru yang disebabkan oleh kelainan jantung. Semua kriteria berikut harus dipenuhi: 1. Diagnosis tegas dari Sindrom Eisenmenger dikonfirmasi oleh Konsultan Kardiovaskular; dan 2. Terdapat riwayat penyakit jantung <i>shunt</i> kiri ke kanan sebelum tanggal Diagnosis Sindrom Eisenmenger.		

	Diagnosis penyakit jantung <i>shunt</i> kiri ke kanan harus didukung oleh <i>ekokardiogram</i> atau studi bayangan lain yang dapat diandalkan; dan 3. Terdapat bukti dari <i>shunt</i> terbalik (dari <i>shunt</i> kiri-kanan ke <i>shunt</i> kanan-kiri) yang baru terjadi pada tanggal Diagnosis Sindrom Eisenmenger; dan 4. Sindrom Eisenmenger telah berkembang ke tahap yang tidak dapat dipulihkan kembali (<i>irreversible</i>)/permanen dan tidak ada operasi yang tersedia untuk memperbaiki kelainan tersebut; dan 5. Adanya gangguan fisik permanen yang diklasifikasikan sebagai NYHA IV. Klasifikasi NYHA untuk Gangguan Jantung: 1. Kelas I: Tidak ada batasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan kelelahan yang tidak semestinya, dyspnea, atau nyeri angina (angina duduk). 2. Kelas II: Sedikit membatasi aktivitas fisik. Aktivitas fisik biasa menghasilkan gejala. 3. Kelas III: Batasan aktivitas fisik yang ditandai. Nyaman saat istirahat, tetapi aktivitas yang kurang dari biasanya menyebabkan gejala. 4. Kelas IV: Tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa rasa tidak nyaman. Gejala dapat muncul bahkan saat istirahat.		
--	---	--	--

F. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Neoplasma (Tumor) dan Kanker

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
37	<i>Cerebral Metastasis</i> Komplikasi kanker sistemik yang menyebar ke otak. Diagnosis harus dipastikan oleh Dokter Spesialis Onkologi dan didukung dengan laporan patologi yang valid. Jika biopsi lesi tidak diindikasikan secara klinis, klaim tersebut harus didukung dengan bukti peningkatan ukuran tumor dan memburuknya disfungsi neurologis. Metastasis Serebral tidak menjadi jaminan jika Tertanggung juga mengidap infeksi HIV atau AIDS.	25	Kanker Kandung Kemih Tahap Awal Kanker kandung kemih yang secara histologis diklasifikasikan sebagai T1N0M0 (klasifikasi TNM).

38	Kanker Suatu tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan dan penyebaran sel-sel ganas yang tidak terkontrol serta adanya invasi dan kerusakan jaringan normal. Kanker harus dipastikan dengan bukti keganasan histologi pada hasil patologi. Kanker yang didiagnosis berdasarkan temuan sel tumor dan/atau molekul terkait tumor dalam darah, air liur, feses, urin, atau cairan tubuh lainnya tanpa adanya bukti definitif lebih lanjut dan dapat diverifikasi secara klinis tidak memenuhi definisi di atas. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Kanker: 1. Pra-ganas; 2. Non-invasif; 3. Karsinoma in-situ (Tis) atau Ta; 4. Diambang batas keganasan; 5. Memiliki potensi keganasan pada tingkat tertentu; 6. Memiliki kecurigaan kearah keganasan; 7. Leukemia Limpositik Kronik (<i>Chronic Lymphocytic Leukemia</i>) yang kurang dari Rai derajat 3; atau 8. Karsinoma in-situ (termasuk displasia leher rahim CIN-1, CIN-2 dan CIN-3) atau yang secara histologi menunjukkan pra keganasan; atau 9. Semua tumor yang terkait dengan infeksi HIV; 10. Hiperkeratosis, kanker sel basal, kanker kulit skuamosa dan melanoa yang berukuran kurang dari 1,5mm (satu koma lima milimeter) ketebalan <i>Breslow</i> atau kurang dari Clark level 3, kecuali ada bukti bahwa telah ada metastasis; atau 11. Kanker prostat yang secara histologi menunjukkan klasifikasi TNM T1N0M0 atau kurang atau klasifikasi lain yang lebih ringan; atau 12. Seluruh tumor tiroid yang secara histologi menunjukkan klasifikasi TNM T1N0M0 atau kurang; atau 13. Seluruh tumor kandung kemih yang secara histologi menunjukkan klasifikasi TNM T1N0M0 atau kurang; atau 14. Kanker gastrointestinal struma tumor (<i>GIST – Malignant Gastrointestinal Stromal Tumours</i>) dan kanker	26 Melanoma Tahap Awal Melanoma invasif dengan ketebalan <i>Breslow</i> kurang dari 1,5 mm (satu koma lima millimeter) atau kurang dari <i>Clark Level</i> 3 (tiga) yang memerlukan tindakan bedah.
----	---	---

	karsinoid tumor yang menunjukkan klasifikasi kurang dari AJCC derajat 2 (dua). 15. Seluruh tumor Neuroendokrin yang secara histologis diklasifikasikan sebagai T1N0M0 atau kurang; 16. Seluruh keganasan sumsum tulang yang tidak memerlukan transfusi darah berulang, kemoterapi, <i>targeted cancer therapy</i>, transplantasi sumsum tulang, transplantasi <i>stem cell</i> hematopoietik, atau pengobatan intervensi utama lainnya;		
39	<i>Pheochromocytoma</i> <i>Pheochromocytoma</i> adalah tumor yang berasal dari sel <i>chromaffin</i> penghasil <i>catecholamine</i> di medula adrenal. Diagnosis <i>Pheochromocytoma</i> harus dikonfirmasi oleh ahli endokrin dan harus menjalani operasi untuk mengangkat tumor. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>pheochromocytoma</i>: Tumor neuroendokrin (NET) secara khusus.	27	Kanker Tiroid Tahap Awal Kanker tiroid yang secara histologi sesuai dengan klasifikasi TNM sebagai T1N0M0 serta microcarcinoma papiler tiroid yang mempunyai diameter kurang dari 1 cm (satu sentimeter).
40	Tumor Otak Jinak (<i>Benign Brain Tumor</i>) Tumor otak jinak berarti tumor tidak ganas yang terletak di kubah tengkorak dan terbatas pada otak, meninges, atau saraf tengkorak dimana semua kondisi dibawah ini harus terpenuhi: 1. Sudah dilakukan operasi pengangkatan tumor atau jika tidak dapat dioperasi harus menyebabkan gangguan permanen saraf; dan 2. Diagnosis Adanya tumor yang mendasarinya harus ditegakkan oleh dokter spesialis saraf atau bedah saraf dan ditunjang oleh hasil pada pemeriksaan MRI kepala, <i>CT Scan</i> atau teknik pencitraan lain yang setara. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari tumor otak jinak: 1. Kista otak; atau 2. Abses otak; atau 3. Angioma otak; atau 4. Granuloma otak; atau	28	Kanker Prostat Tahap Awal Kanker prostat yang secara histologi sesuai dengan klasifikasi TNM sebagai T1N0M0 atau kanker prostat yang dijelaskan menggunakan klasifikasi lain yang setara dengan klasifikasi TNM. Keadaan dibawah ini dikecualikan dari Kanker Prostat: Neoplasia Intraepitel Prostat (<i>Prostatic Intraepithelial Neoplasia/PIN</i>)

	5. Hematoma otak; atau 6. Tumor dari <i>spinal cord</i> ; atau 7. Malformasi di arteri atau vena otak; atau 8. Tumor kelenjar pituitari; atau 9. Tumor dasar tengkorak.		
		29	Karsinoma In Situ Karsinoma in situ berarti fokus pertumbuhan baru otonom sel karsinoma terbatas pada sel-sel di mana dia berasal dan belum menghasilkan atau belum terjadi invasi dan/atau kerusakan jaringan sekitarnya. Invasi berarti infiltrasi dan/atau perusakan aktif jaringan normal di luar membran basal. Diagnosis karsinoma in situ harus selalu didukung oleh hasil biopsi berupa laporan histopatologi. Selain itu, diagnosis karsinoma in situ harus selalu didiagnosis secara positif berdasarkan pemeriksaan mikroskopis dari jaringan tetap, didukung oleh hasil biopsi. Diagnosis klinik tidak memenuhi standar ini. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari karsinoma in situ: - Neoplasia Intraepitel Prostat (<i>Prostatic Intraepithelial Neoplasia/PIN</i>); - Karsinoma in situ non-melanoma; - Karsinoma in situ pada sistem empedu; - CLL RAI stadium 0 (nol) atau lebih rendah; - Diagnosis klinis atau serviks intraepithelial neoplasia (CIN) klasifikasi yang menerangkan CIN I, CIN II, dan III CIN (displasia berat tanpa karsinoma in situ); atau - Neoplasia Intraepitel Vulva (<i>Vulvar Intra-epithelial Neoplasia/VIN</i>); atau - Setiap lesi (<i>lesion</i>) atau tumor yang secara histologis dideskripsikan sebagai lesi jinak, lesi tingkat rendah, displasia, <i>pre-malignant</i>, <i>borderline malignant</i>, atau potensi <i>malignat</i> pada

			tingkat apa pun.
		30	<i>Lymphocytic</i> Leukimia Kronis Tahap Awal <i>Lymphocytic</i> leukemia kronis tahap awal yang dimaksud dalam Pertanggungjawaban ini adalah lymphocytic leukemia kronis (CLL) RAI tahap 1 (satu). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Lymphocytic</i> Leukimia Kronis Tahap Awal: CLL RAI tahap 0 (nol) atau lebih rendah.

G. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Paru-Paru

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
		31	Operasi Pengangkatan Satu Paru-Paru Operasi pengangkatan satu paru-paru adalah operasi seluruh pengangkatan paru-paru kanan atau paru-paru kiri sebagai akibat dari suatu Penyakit atau Kecelakaan. Pengangkatan sebagian paru-paru tidak termasuk dalam manfaat ini.
41	Penyakit Paru Stadium Akhir (<i>End Stage Lung Disease</i>) Penyakit paru stadium akhir, yang menyebabkan kegagalan pernapasan kronis. Diagnosis ini harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis paru-paru dan didukung oleh semua bukti di bawah ini: 1. Volume Ekspirasi Paksa 1 (satu) (FEV1 = <i>Forced Expired Volume 1</i>) selalu kurang dari 1 (satu) liter; dan 2. Memerlukan terapi tambahan oksigen secara permanen untuk hiposekemia (penurunan tekanan parsial oksigen dalam darah); dan 3. Analisa gas darah arteri harus menunjukkan tekanan oksigen parsial 55 mmHg atau kurang (PaO₂ < 55 mmHg) dan 4. Harus ada sesak napas saat istirahat.		

H. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Sistem Saraf

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
42	Amiotrofi Spinal Tipe 1 Tertanggung harus didiagnosis mengidap amiotrofi spinal anak tipe 1 (satu) yang merupakan bentuk <i>infantil</i> (kanak-kanak) dari atrofi muskular		

	tulang belakang yang dicirikan dengan disfungsi progresif dari sel tanduk anterior pada susunan tulang belakang dan saraf-saraf Kranial batang otak dengan kelemahan dan disfungsi bulbar yang tampak jelas. <i>Elektromiografi</i> dengan Biopsi otot dibutuhkan untuk mengkonfirmasi diagnosis ini. Pertanggungungan atas Penyakit ini akan berakhir pada saat ulang tahun Tertanggung yang ke-21 (dua puluh satu) tahun.		
		32	<i>Akinetic Mutism</i> Kerusakan otak organik yang menyebabkan seseorang tidak dapat berbicara atau bergerak walaupun tampak sadar pada waktu tertentu. Diagnosis ini harus ditegakkan oleh bukti yang menunjukkan kerusakan otak organik dan dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis saraf dan kondisi ini harus berlangsung secara terus-menerus selama paling sedikit 1 (satu) bulan menurut catatan medis. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit <i>akinetic mutism</i>: <i>Akinetic mutism</i> karena alasan psikologis.
43	<i>Amyotropic Lateral Sclerosis</i> Diagnosis yang ditegakkan oleh Dokter Spesialis saraf yang memastikan adanya kelainan saraf dengan tanda-tanda persisten terkenanya sistem saraf tulang belakang dan pusat motorik di otak dan serta adanya kelemahan yang kaku dan penyusutan otot-otot anggota gerak. Diagnosis harus dibuat melalui pemeriksaan yang berhubungan dengan otot dan saraf yang sesuai seperti <i>elektromiografi</i> (EMG). Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk melakukan tanpa bantuan 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus.		
44	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan Otak (<i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i>) Pembedahan otak untuk memperbaiki pelebaran yang tidak normal dari	33	Perawatan Endovaskular untuk Aneurisma Serebral Perawatan endovaskular untuk aneurisma serebral adalah tindakan intervensi endovaskular, seperti embolisasi endovaskular, <i>coiling</i>

	pembuluh darah arteri cerebral yang melibatkan semua lapisan dari tiga lapisan dinding pembuluh darah arteri cerebral. Diagnosis harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis saraf dengan menggunakan pemeriksaan standar cerebral angiography dimana hasil pemeriksaan tersebut mengindikasikan untuk dilakukan operasi terbuka. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan Otak: 1. Infeksi dan mycotic aneurisma 2. Kraniotomi terbatas dan prosedur operasi <i>Burr Hole</i>.		endovaskular, angioplasti dan/atau <i>stenting</i> atau penyisipan alat <i>flow diverter</i>, untuk mencegah pecahnya aneurisme serebral atau untuk mengurangi perdarahan karena pecahnya aneurisme serebral. Tindakan harus atas indikasi medis dan dilakukan oleh Dokter Spesialis di bidang terkait.
		34	Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Memerlukan Pembedahan (<i>Brain Aneurysm Surgery</i>) Menjalani bedah kraniotomi untuk menjepit, memperbaiki atau mengangkat baik aneurisma serebral maupun malformasi arteri-vena atau menjalani <i>gamma knife radiosurgery</i> untuk menghancurkan malformasi arteri-vena. Intervensi bedah harus diperlukan secara medis dan atas anjuran Dokter Spesialis saraf. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Memerlukan Pembedahan (<i>Brain Aneurysm Surgery</i>): 1. Tindakan selain kraniotomi atau <i>gamma knife radiosurgery</i>, atau 2. Perbaikan atau tindakan endovaskular.
45	Demensia Parah (<i>Severe Dementia</i>) Kemunduran progresif atau hilangnya kapasitas intelektual atau perilaku abnormal sebagaimana dibuktikan oleh keadaan klinis dan penerimaan kuesioner atau tes standar yang timbul dari kelainan otak degeneratif organik yang tidak dapat disembuhkan, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam fungsi mental dan sosial yang memerlukan perawatan dan pengawasan berkelanjutan terhadap tertanggung jiwa. Diagnosis harus dipastikan secara klinis oleh konsultan yang tepat dan didukung oleh dokter		

	yang ditunjuk Perusahaan. Demensia yang disebabkan oleh penyakit kejiwaan, penggunaan obat-obatan atau alkohol, atau kelainan otak organik yang dapat disembuhkan tidak termasuk.		
		35	Bedah Eksisi pada Meningioma Tulang Belakang (<i>Spinal Meningioma</i>) Tindakan bedah eksisi pada meningioma tulang belakang (<i>spinal meningioma</i>) oleh Dokter Spesialis bedah saraf. Diagnosis <i>spinal meningioma</i> harus didukung dengan hasil <i>CT Scan</i> atau <i>MRI</i> dan bukti histopatologi.
46	<i>Guillain- Barre Syndrome</i> Suatu kelainan yang ditandai dengan kelumpuhan simetris progresif dan hilangnya refleks akibat kerusakan saraf tepi dan akar tulang belakang. Seorang ahli saraf bersertifikat harus membuat diagnosis tegas sindrom Guillain-Barre dan diagnosis tersebut harus diverifikasi dengan kelainan khas pada studi konduksi saraf. Juga harus terdapat defisit neurologis fungsional yang parah dan permanen dengan tanda-tanda motorik atau sensorik yang tidak normal pada pemeriksaan objektif oleh ahli saraf bersertifikat 3 (tiga) bulan setelah diagnosis awal penyakit.		
		36	Bedah untuk Pengangkatan Tumor Hipofisis Menjalani bedah pengangkatan tumor hipofisis yang diharuskan akibat gejala yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh tumor. Keberadaan tumor yang mendasarinya harus dikonfirmasi oleh pemeriksaan <i>imaging</i> seperti <i>CT Scan</i> atau <i>MRI</i> . Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Bedah untuk Pengangkatan Tumor Hipofisis: Pengangkatan sebagian hipofisis mikroadenoma.
47	Kematian Jaringan Korteks Otak (<i>Apallic Syndrome</i>) Kematian jaringan luas pada korteks otak namun batang otak tetap baik dan kondisinya telah berlangsung paling		

	sedikit selama 1 (satu) bulan. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis saraf.		
48	Koma Selama 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) Jam Ketidaksadaran yang ditandai dengan hilangnya reaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam dan penggunaan alat-alat bantu kehidupan sekurang-kurangnya selama 192 (seratus sembilan puluh dua) jam, yang mengakibatkan terjadinya penurunan tetap fungsi saraf yang dipastikan oleh Dokter Spesialis saraf. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Koma Selama 192 (seratus sembilan puluh dua) Jam: Koma yang disebabkan oleh alkohol atau penyalahgunaan obat.	37	Koma Selama 48 (Empat Puluh Delapan) Jam Koma yang berlangsung selama 48 (empat puluh delapan) jam berturut-turut atau lebih. Diagnosis ini harus didukung oleh semua bukti yang disebutkan berikut ini: 1. Tidak ada respon terhadap rangsangan dari luar selama 48 (empat puluh delapan) jam berturut-turut atau lebih; dan 2. Penggunaan alat-alat bantu kehidupan untuk mempertahankan hidup; dan 3. Kerusakan otak yang mengakibatkan penurunan fungsi sistem saraf permanen yang harus dinilai paling sedikit 30 (tiga puluh) hari setelah onset dari koma. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Koma Selama 48 (empat puluh delapan) Jam: 1. Koma yang diakibatkan secara langsung dari penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan; atau 2. Koma yang timbul akibat dari induksi medis.
49	<i>Multiple Sclerosis</i> Suatu Penyakit akibat rusaknya selaput saraf pada jaringan saraf otak. Dokter Spesialis saraf harus menegakkan diagnosis yang dibuktikan dengan riwayat lengkap dari eksaserbasi atau bertambah parahnya Penyakit dan remisi atau meredanya Penyakit. Pemeriksaan seperti <i>Magnetic Resonance Imaging</i>, <i>Computerised Tomography</i>, atau teknik <i>imaging</i> lainnya harus memastikan diagnosis dengan tepat. Harus ada bukti tanda-tanda gangguan saraf paling sedikit selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Multiple Sclerosis</i>. Penyebab kerusakan saraf lainnya seperti SLE dan HIV.		

50	<i>Muscular Atrophy</i> Progresif Penyakit yang ditandai dengan mengecilnya atau menyusutnya otot-otot dan kekakuan secara progresif. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk tanpa bantuan melakukan 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus, dan diagnosis dibuat oleh Dokter Spesialis saraf serta harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan otot dan saraf yang sesuai seperti elektromiografi (EMG).	38	<i>Muscular Atrophy</i> Progresif yang Cukup Berat Penurunan fungsi otot yang ditandai dengan makin melemahnya dan mengecilnya otot. Kondisi ini harus mengakibatkan adanya ketidakmampuan permanen untuk melakukan tanpa bantuan paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus Diagnosis dari penurunan fungsi otot harus dengan pasti dan dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan otot dan saraf seperti elektromiografi (EMG).
51	<i>Muscular Atrophy</i> Spinal Gangguan degeneratif yang progresif dan menetap pada sel-sel cornu anterior di tulang belakang dan nuclei motorik batang otak, yang ditandai dengan melemahnya dan mengecilnya otot-otot proksimal yang jelas, terutama pada anggota gerak bawah, yang diikuti dengan otot-otot distal. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dan dipastikan dengan pemeriksaan otot dan saraf (neuromuscular) yang sesuai seperti elektromiografi (EMG).		
52	<i>Muscular Dystrophy</i> Sekumpulan Penyakit penurunan fungsi otot karena faktor keturunan yang ditandai dengan makin melemahnya dan mengecilnya otot. Diagnosis dari penurunan fungsi otot harus dengan pasti dan dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan otot dan saraf yang sesuai seperti <i>elektromiografi</i> (EMG). Kondisi tersebut harus mengakibatkan ketidakmampuan menetap yang sedikitnya harus telah berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus untuk tanpa bantuan melakukan 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus.	39	<i>Moderately Severe Muscular Dystrophy</i> Sekumpulan Penyakit penurunan fungsi otot karena faktor keturunan yang ditandai dengan makin melemahnya dan mengecilnya otot. Diagnosis dari penurunan fungsi otot harus dengan pasti dan ditegakkan oleh Dokter Spesialis saraf dan didukung dengan pemeriksaan otot dan saraf yang sesuai seperti elektromiografi (EMG). Kondisi tersebut harus mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk melakukan tanpa bantuan 2 (dua) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus yang telah berlangsung minimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus.
53	<i>Myasthenia Gravis</i> Gangguan autoimun yang merusak komunikasi antara saraf dan otot,	40	<i>Myasthenia Gravis</i> Tahap Awal Gangguan auto-imun yang merusak hubungan neuromuskular, yang

	mengakibatkan kelemahan otot (Kelas IV atau Kelas V) sesuai klasifikasi <i>Myasthenia Gravis Foundation of America</i> (MGSA). Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dan harus ditegakkan dengan pemeriksaan otot dan saraf yang sesuai seperti elektromiografi (EMG). Klasifikasi myasthenia gravis menurut <i>Myasthenia Gravis Foundation of America</i> (MGSA): Kelas I: Kelemahan otot mata, kemungkinan <i>ptosis</i>, namun kekuatan otot lainnya dalam batas normal. Kelas II: Kelemahan ringan dari otot lain, dapat disertai kelemahan otot mata - Ila: Sebagian besar otot tungkai atau otot aksial atau keduanya; - IIb: Sebagian besar orofaring atau otot pernapasan, atau keduanya. Kelas III: Kelemahan sedang dari otot lain, dapat disertai kelemahan otot mata - IIIa: Sebagian besar otot tungkai atau otot aksial atau keduanya; - IIIb: Sebagian besar orofaring atau otot pernapasan, atau keduanya. Kelas IV: Kelemahan berat dari otot lain, dapat disertai kelemahan otot mata - IVa: Sebagian besar otot tungkai atau otot aksial atau keduanya; - IVb: Sebagian besar orofaring atau otot pernapasan, atau keduanya; penggunaan selang untuk makan tanpa intubasi pernapasan. Kelas V: Membutuhkan intubasi untuk mempertahankan jalan napas.	
	mengakibatkan kelemahan otot permanen, diklasifikasikan sebagai kelas III berdasarkan Klasifikasi Klinis <i>Myasthenia Gravis Foundation of America</i> (MGSA). Diagnosis harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis saraf dan didukung oleh pemeriksaan neuromuskular seperti elektromiografi (EMG). Klasifikasi myasthenia gravis menurut <i>Myasthenia Gravis Foundation of America</i> (MGSA): Kelas I: Kelemahan otot mata, kemungkinan <i>ptosis</i>, namun kekuatan otot lainnya dalam batas normal. Kelas II: Kelemahan ringan dari otot lain, dapat disertai kelemahan otot mata - Ila: Sebagian besar otot tungkai atau otot aksial atau keduanya; - IIb: Sebagian besar orofaring atau otot pernapasan, atau keduanya. Kelas III: Kelemahan sedang dari otot lain, dapat disertai kelemahan otot mata - IIIa: Sebagian besar otot tungkai atau otot aksial atau keduanya; - IIIb: Sebagian besar orofaring atau otot pernapasan, atau keduanya. Kelas IV: Kelemahan berat dari otot lain, dapat disertai kelemahan otot mata - IVa: Sebagian besar otot tungkai atau otot aksial atau keduanya; - IVb: Sebagian besar orofaring atau otot pernapasan, atau keduanya; penggunaan selang untuk makan tanpa intubasi pernapasan. Kelas V: Membutuhkan intubasi untuk mempertahankan jalan napas.	41 Pemasangan <i>Shunt</i> di dalam Otak Besar (<i>Cerebral Shunt Insertion</i>) Menjalani implantasi bedah <i>shunt</i> dari ventrikel otak untuk mengurangi peningkatan tekanan dalam cairan serebrospinal. Tindakan <i>cerebral shunt</i>

			harus atas indikasi medis dan atas anjuran Dokter Spesialis saraf.
54	Operasi Otak (<i>Brain Surgery</i>) Pembedahan jaringan otak secara kraniotomi dengan anestesi umum yang baru saja berlangsung. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Operasi Otak (<i>Brain Surgery</i>): 1. Tindakan <i>Burr Hole</i>, tindakan <i>transphenoidal</i> dan tindakan minimal invasif lainnya; atau 2. Pembedahan otak yang terjadi sebagai akibat dari Kecelakaan.; atau 3. Biopsi stereotaktik atau aspirasi otak.	42	Pembedahan untuk Epilepsi Resisten Obat (<i>Drug Resistant Epilepsy/ DRE</i>) Tindakan pembedahan pada jaringan otak (termasuk operasi <i>gamma knife</i>) untuk mengontrol epilepsi parah yang tidak dapat dikontrol dengan pengobatan oral, harus ada dokumentasi kejang <i>tonik-klonik</i> atau <i>grand mal</i> berulang yang resisten terhadap terapi optimal, dan Tertanggung harus telah meminum setidaknya 2 (dua) obat anti epilepsi (anti kejang) yang diresepkan selama minimal 6 (enam) bulan atas rekomendasi dari Dokter Spesialis saraf.
		43	Pembedahan Pada Sistem Saraf Menjalani salah satu dari keadaan berikut ini: 1. Pembedahan <i>Burr Hole</i> pada tengkorak atau pembedahan transphenoidal untuk pemasangan <i>shunt</i>, untuk mengangkat hematoma subdural, pertumbuhan abnormal atau lesi. Pengangkatan sebagian mikroadenoma hipofisis dan operasi endovaskular secara khusus dikecualikan. 2. Endarterektomi arteri karotis yang diperlukan akibat penyempitan arteri karotis minimal 80% (delapan puluh persen) yang didiagnosis dengan arteriografi atau tes diagnostik lain yang sesuai dengan akurasi diagnostik yang sama atau lebih tinggi yang tersedia. Endarterektomi pembuluh darah selain arteri karotis secara khusus dikecualikan. Tindakan harus atas indikasi medis dan dilakukan oleh Dokter Spesialis di bidang terkait.
55	Operasi Skoliosis Idiopatik (<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>) Operasi Skoliosis Idiopatik (yang tidak diketahui penyebabnya) di mana dilakukan dengan operasi spinal untuk mengkoreksi curvature tulang belakang yang tidak normal kembali ke bentuk normal (berbentuk garis lurus yang tampak dari punggung). Yang dimaksud kondisi skoliosis dalam Ketentuan Polis		

	ini adalah posisi kurva tulang belakang melebihi dari 40 (empat puluh) derajat sudut <i>cobb</i> . Operasi skoliosis idiopatik harus berdasarkan konfirmasi diperlukan secara medis dari seorang Dokter Spesialis bedah ortopedi.		
56	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer Disease</i>) Penurunan atau kehilangan kapasitas intelek atau kelakuan abnormal yang progresif dibuktikan dengan kondisi klinis dan daftar pertanyaan khusus atau pemeriksaan khusus dengan standar yang bisa diterima untuk Penyakit alzheimer atau kelainan organik degeneratif otak yang permanen dan menetap (<i>irreversible</i>), yang mengakibatkan penurunan fungsi sosial dan mental yang bermakna yang memerlukan perawatan berkelanjutan dan pengawasan terhadap Tertanggung. Diagnosis harus dibuat secara klinis oleh Dokter Spesialis yang sesuai. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer Disease</i>): Faktor kejiwaan (psikiatris) atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau mengonsumsi minuman mengandung alkohol atau gangguan organik otak yang tidak menetap (<i>reversible</i>).	44	Penyakit Alzheimer yang Cukup Berat atau Demensia Diagnosis pasti Penyakit alzheimer yang cukup berat atau demensia akibat gangguan otak organik ireversibel harus ditegakkan oleh seorang Dokter Spesialis saraf. Penilaian dari uji mini-mental harus kurang dari 20 (dua puluh) atas skala 30 (tiga puluh) atau yang setara dengan nilai ini bila menggunakan tes lain alzheimer. Diagnosis secara klinis Penyakit alzheimer yang cukup berat atau demensia harus mencakup keadaan kehilangan kemampuan permanen untuk melakukan semua hal di bawah ini: - Mengingat; dan - Berpikir atau memberikan alasan; dan - Merasakan, memahami, mengekspresikan dan memberi respon terhadap ide-ide. Diagnosis Penyakit alzheimer yang cukup berat atau demensia harus didukung oleh konfirmasi klinis konsultan yang sesuai dan didukung oleh Dokter yang ditunjuk Penanggung. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit Alzheimer yang cukup berat atau demensia: - Penyakit non-organik seperti neurosis dan Penyakit kejiwaan; atau - Kerusakan otak yang berhubungan dengan alkohol.
57	Penyakit Parkinson (<i>Parkinson Disease</i>) Proses degenerasi fungsi sistem saraf pusat akibat hilangnya zat warna (pigmen) yang mengandung sel neuron otak. Diagnosis pasti harus dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dengan kondisi: tidak dapat disembuhkan dengan	45	Penyakit Parkinson Cukup Berat Penyakit degeneratif sistem saraf pusat sebagai akibat dari hilangnya pigmen yang mengandung neuron otak, harus disertai diagnosis pasti dari seorang Dokter Spesialis saraf, dan mencakup kondisi:

	obat-obatan; dan - menunjukkan adanya tanda-tanda penyimpangan yang progresif; dan - ketidakmampuan menetap yang sedikitnya harus berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus untuk tanpa bantuan melakukan 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus. Hanya Penyakit <i>Parkinson Idiopathic</i> yang ditanggung. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit parkinson: - Keracunan atau akibat samping obat-obatan yang menyebabkan terjadinya Penyakit parkinson; - Penyakit parkinson sekunder; atau - Penyakit parkinson herediter.		- Tidak bisa dikendalikan dengan obat-obatan; dan - Menunjukkan tanda-tanda penurunan progresif; dan - Ada ketidakmampuan permanen untuk melakukan tanpa bantuan 1 (satu) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus minimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari terus menerus. Hanya penyakit <i>Parkinson Idiopathic</i> yang ditanggung. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Penyakit Parkinson Cukup Berat: - Keracunan atau akibat samping dari obat-obatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Penyakit parkinson; atau - Penyakit parkinson sekunder; atau - Penyakit parkinson herediter.
58	Penyakit Huntington Anak Diagnosis Penyakit huntington anak dengan tes genetik dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis anak dan harus ada semua bukti berikut: - Gangguan pergerakan akibat Penyakit huntington anak; dan - Gangguan kognitif akibat Penyakit huntington anak; dan - Gangguan perilaku akibat Penyakit huntington anak. Pertanggung jawaban atas Penyakit ini akan berakhir pada saat ulang tahun Tertanggung yang ke-21 (dua puluh satu) tahun.		
59	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>) Mengacu pada degenerasi progresif saluran kortikospinal dan sel tanduk anterior atau neuron eferen bulbar. Ini termasuk atrofi otot tulang belakang, kelumpuhan bulbar progresif, sklerosis lateral amiotrofik, dan sklerosis lateral primer. Diagnosis harus dipastikan oleh ahli saraf sebagai diagnosis yang progresif dan mengakibatkan defisit neurologis		

	permanen.		
60	Primary Lateral Sclerosis Gangguan degeneratif yang progresif dan menetap pada motor neuron korteks otak yang berakibat pada meluasnya kelemahan otot-otot dari motor neuron bagian atas dengan penurunan fungsi saraf secara permanen, secara klinis ditandai dengan kelemahan anggota gerak spastik progresif, yang didahului atau diikuti oleh dysarthria spastik dan dysphagia, yang menunjukkan keterlibatan jalur kortikospinal dan kortikobulbar, diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dan dipastikan dengan pemeriksaan otot dan saraf (neuromuscular) yang sesuai seperti elektromiografi (EMG).		
61	Progressive Bulbar Palsy Degenerasi secara progresif pada otot-otot termasuk otot-otot bulbar yang didiagnosis dibuat oleh Dokter Spesialis saraf. Diagnosis tersebut dinyatakan sebagai progresif dan mengakibatkan penurunan fungsi saraf secara permanen serta dipastikan dengan pemeriksaan otot dan saraf yang sesuai seperti elektromiografi (EMG).		
62	Progressive Supranuclear Palsy (PSP) <i>Progressive Supranuclear Palsy</i> yang terjadi secara independen dari semua penyebab lain dan mengakibatkan defisit neurologis permanen serta secara langsung bertanggung jawab atas ketidakmampuan permanen untuk melakukan setidaknya 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus. Diagnosis tegas dari <i>progressive supranuclear palsy</i> harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis saraf.	46	Kelumpuhan Supranuklear Progresif yang Tidak Terlalu Parah (<i>Less Severe Progressive Supranuclear Palsy</i>) Penyakit neurologis degeneratif yang ditandai dengan paresis pandangan supranuklear, kelumpuhan pseudobulbar, kekakuan aksial, dan demensia. Diagnosis pasti Kelumpuhan Supranuklear Progresif Kurang Parah harus dipastikan oleh konsultan ahli saraf. Kondisi tersebut harus mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk melakukan, tanpa bantuan, setidaknya 2 (dua) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus untuk jangka waktu terus menerus minimal 6 (enam) bulan.
63	Stroke Gangguan pembuluh darah otak termasuk kematian jaringan otak, pendarahan otak dan <i>subarachnoid</i>, embolisasi otak dan trombosis otak yang		

	mengakibatkan gangguan permanen fungsi sistem saraf, yang harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis saraf paling sedikit 6 (enam) minggu setelah kejadian. Diagnosis harus didukung oleh hasil <i>Magnetic Resonance Imaging, Computerised Tomography</i> atau teknik <i>Imaging</i> lainnya yang sesuai dengan diagnosis stroke. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Stroke</i>: <i>Transient Ischaemic Attacks</i> dan <i>Reversible Ischaemic Neurological Deficit</i>; atau - Kerusakan otak akibat Kecelakaan atau luka, infeksi, <i>vasculitis</i>, Penyakit peradangan dan <i>migraine</i>; atau - Kelainan serabut saraf penglihatan atau pembuluh darah yang mempengaruhi organ mata; atau - Kelainan <i>Ischaemic</i> sistem <i>vestibular</i>.		
64	<i>Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid</i> <i>Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid</i> adalah stroke yang baru terjadi dan dilakukan pembedahan endarterektomi karotis terbuka yang dilakukan oleh spesialis bedah saraf yang terdaftar. Stroke baru dan keperluan untuk pembedahan harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan pencitraan yang sesuai untuk stroke. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid</i>: Prosedur vascular intra-arteri perkutaneus.		
65	<i>Surgical removal of an Arterio-Venous Malformation or Brain Aneurysm via Craniotomy</i> Operasi kraniotomi untuk memotong, memperbaiki atau mengangkat aneurisma otak atau malformasi arterio-vena; atau operasi <i>radiosurgery Gamma Knife</i> untuk memperbaiki malformasi arteriovenosa. Intervensi bedah harus dinyatakan perlu secara medis oleh spesialis saraf.	47	Bedah untuk Hematoma Subdural Menjalani bedah <i>Burr Hole</i> pada kepala untuk drainase hematoma subdural akibat kecelakaan. Keperluan untuk bedah <i>Burr Hole</i> harus dibuktikan sebagai indikasi medis oleh seorang Dokter Spesialis di bidang yang relevan.

	Keadaan dibawah ini dikecualikan dari <i>Surgical removal of an Arterio-Venous Malformation or Brain Aneurysm via Craniotomy</i>: 1. Prosedur selain kraniotomi atau bedah radio <i>Gamma Knife</i>; atau 2. Perbaikan atau prosedur endovaskular tidak ditanggung.		
66	Trauma Berat pada Kepala (<i>Major Head Trauma</i>) Cedera pada kepala yang disebabkan oleh Kecelakaan yang berakibat pada defisit dan/atau gangguan fungsi saraf yang menetap paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya Kecelakaan. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis saraf dan didukung oleh hasil pemeriksaan MRI dan/atau <i>CT Scan</i> Kepala yang sesuai dengan trauma berat pada kepala. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari Trauma Berat Pada Kepala: a. Cedera pada <i>spinal cord</i>; atau b. Gangguan pada kepala dikarenakan oleh penyebab lainnya.		

I. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Sistem Sensorik dan Disabilitas

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
67	Hilangnya Kemampuan Bicara (<i>Loss of Speech</i>) Hilangnya kemampuan bicara total dan menetap akibat kerusakan fisik pita suara yang berlangsung secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan. Bukti medis harus diberikan oleh Dokter Spesialis yang menyatakan luka atau Penyakit pada pita suara. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Hilangnya Kemampuan Bicara: Hilangnya kemampuan bicara akibat faktor kejiwaan (<i>psychiatric</i>).	48	Kehilangan Kemampuan Bicara Karena Sebab Apapun Hilangnya kemampuan untuk berbicara secara total dan permanen akibat Penyakit atau Cedera yang berlangsung secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan. Bukti medis harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Kehilangan Kemampuan Bicara Karena Sebab Apapun: Hilangnya kemampuan bicara akibat faktor kejiwaan.
68	Hilangnya Pendengaran (<i>Loss of Hearing</i>) Hilangnya pendengaran (tuli) total dan menetap kedua telinga terhadap seluruh macam bunyi (dengan atau tanpa alat bantu), sebagai akibat Penyakit yang akut atau Kecelakaan. Bukti medis harus	49	Operasi Implantasi Koklea Tindakan penanaman koklea sebagai akibat dari kerusakan permanen pada selaput telinga (<i>cochlea</i>) atau saraf pendengaran. Prosedur operasi dan penanaman harus dilakukan oleh Dokter Spesialis telinga, hidung, dan

	diberikan oleh Dokter Spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), termasuk uji audiometris dan uji ambang-terima bunyi (<i>sound-threshold</i>). Total berarti "hilangnya pendengaran hingga suara paling rendah yang dapat didengar adalah 80 (delapan puluh) desibel atau lebih di semua frekuensi".		tenggorokan (THT).
		50	Kebutaan Tahap Awal - Kehilangan Penglihatan pada Satu Mata Kehilangan penglihatan pada salah satu mata secara total dan tidak dapat dipulihkan kembali (<i>irreversible</i>) dengan ketentuan bahwa kondisi tersebut: 1. Sebagai akibat dari Penyakit atau Kecelakaan; dan 2. Harus didiagnosis oleh Dokter Spesialis mata; dan 3. Bukan disebabkan karena alkohol atau penyalahgunaan narkoba.
69	Kebutaan (<i>Blindness</i>) Hilangnya kemampuan penglihatan (buta) permanen dan tidak dapat pulih kembali (<i>irreversible</i>) pada kedua mata yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau Penyakit. Pada pemeriksaan penglihatan memperoleh hasil 3/60 atau kurang pada kedua mata dengan menggunakan pemeriksaan grafik mata Snellen (<i>Snellen eye chart</i>) atau pemeriksaan yang setara. Kebutaan harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis mata.	51	Atrofi Saraf Optik Diagnosis atrofi pada saraf optik yang memengaruhi kedua mata yang mengakibatkan kebutaan permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali (<i>irreversible</i>) di kedua mata yang ketika diuji dengan alat bantu visual, penglihatannya berkisar 6/60 atau lebih buruk dengan menggunakan grafik <i>Snellen eye</i>. Atrofi saraf optik dan tingkat kehilangan penglihatan harus disertifikasi oleh Dokter Spesialis mata. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Atrofi Saraf Optik: Atrofi Saraf Optik akibat penyalahgunaan alkohol atau obat.
70	Kehilangan Fungsi dari Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan dari Satu Mata Kehilangan secara total dan menetap atas fungsi dari salah satu tungkai dan secara menyeluruh dan kehilangan seluruh penglihatan dari salah satu mata yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan. Kondisi ini harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis yang terkait dengan penyakit tersebut (saraf dan mata). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari	52	Kehilangan Salah Satu Anggota Gerak Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan kembali (<i>irreversible</i>) salah 1 (satu) anggota gerak di atas siku atau di atas lutut dan/atau hilangnya salah 1 (satu) anggota gerak pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki akibat Penyakit atau Cedera. Kondisi ini harus dibuktikan oleh seorang Dokter Spesialis dari bidang kedokteran yang berhubungan.

	Kehilangan Fungsi dari Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan dari Satu Mata: Cedera yang dilakukan oleh diri sendiri.		Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Kehilangan Salah Satu Anggota Gerak: Cedera sebagai akibat dari tindakan melukai diri sendiri.
		53	Kehilangan Sebagian Pendengaran Hilangnya pendengaran permanen binaural dengan kehilangan setidaknya 60 (enam puluh) desibel di semua frekuensi pendengaran akibat Penyakit atau Kecelakaan. Hilangnya pendengaran harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) dan didukung oleh tes diagnostik yang objektif untuk menunjukkan hilangnya kuantum pendengaran.
71	Kelumpuhan (<i>Loss of Limbs</i>) Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan kembali (<i>irreversible</i>) pada 2 (dua) anggota gerak di atas siku atau di atas lutut dan/atau hilangnya 2 (dua) anggota gerak pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki akibat Penyakit atau Cedera. Kondisi ini harus dibuktikan oleh seorang Dokter Spesialis saraf. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Kelumpuhan (<i>Loss of Limbs</i>): Cedera sebagai akibat dari tindakan melukai diri sendiri.		
72	Ketidakmampuan Total dan Tetap (<i>Total and Permanent Disability</i>/TPD) 1. Jika Tertanggung berusia di bawah 16 (enam belas) tahun maka ketidakmampuan total dan tetap didefinisikan sebagai ketidakmampuan yang dialami Tertanggung karena Penyakit atau Cedera yang menurut pendapat Dokter membutuhkan perawatan dan perhatian secara konstan yang terbatas pada perawatan di rumah di bawah pengawasan medis, di rumah sakit atau lembaga sejenis, dan ketidakmampuan harus berlangsung sedikitnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus-menerus. 2. Jika Tertanggung berusia di atas 16 (enam belas) tahun maka ketidakmampuan total dan tetap didefinisikan sebagai	54	Kehilangan Kemandirian Tahap Sedang Kehilangan kemandirian dibuktikan dengan ketidakmampuan permanen dengan atau tanpa bantuan untuk melakukan paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus secara terus-menerus selama paling sedikit 6 (enam) bulan. Diagnosis harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis bidang terkait. Manfaat hanya dapat dibayarkan jika diagnosis pertama terjadi saat Tertanggung berusia 15 (lima belas) tahun hingga 75 (tujuh puluh lima) tahun.

	ketidakmampuan Tertanggung untuk melakukan setidaknya 3 (tiga) dari 5 (lima) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.2 Ketentuan Khusus meskipun dengan bantuan peralatan khusus dan memerlukan bantuan fisik orang lain di seluruh kegiatan tersebut, disebabkan oleh Penyakit atau Cedera, dan berlangsung selama setidaknya 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus. Kondisi ini harus dikonfirmasi oleh seorang Dokter dan didiagnosis sebagai ketidakmampuan total dan tetap.		
		55	Luka Bakar Cukup Berat Luka bakar cukup berat adalah luka bakar derajat 2 (dua) yang meliputi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari permukaan tubuh Tertanggung.
73	Luka Bakar Berat (<i>Major Burns</i>) Luka bakar berat adalah luka bakar derajat 3 (tiga) yang menyebabkan terjadinya kerusakan kulit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kulit.	56	Luka Bakar Sedang Luka bakar sedang adalah luka bakar derajat 3 (tiga) yang memerlukan <i>skin grafting</i> dan mengenai setidaknya 10% (sepuluh persen) dari total permukaan tubuh atau setidaknya 50% (lima puluh persen) dari wajah Tertanggung.
		57	Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavernosus Tindakan pembedahan pada trombosis sinus kavernosus/ <i>cavernosus sinus thrombosis</i> (CST) dengan ketentuan diagnosis tentang adanya trombosis sinus kavernosus dan diperlukannya tindakan pembedahan harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).
		58	Transplantasi Kornea Penerimaan transplantasi seluruh kornea untuk memperbaiki jaringan parut permanen yang mengakibatkan pengurangan ketajaman visual, yang tidak dapat dikoreksi dengan metode lain.

J. Penyakit Kritis yang berhubungan dengan Usus atau Pencernaan

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
74	<i>Colitis Ulcerative Berat (Severe Ulcerative Colitis)</i> <i>Colitis Ulcerative Berat</i> adalah <i>Colitis Ulcerative</i> fulminan akut dengan	59	<i>Mild Ulcerative Colitis</i> <i>Ulcerative Colitis</i> berarti <i>Ulcerative Colitis</i> akut yang mengancam jiwa, gangguan elektrolit biasanya

	gangguan elektrolit yang mengancam nyawa, dengan seluruh kondisi di bawah ini: 1. Seluruh usus besar terpengaruh, dengan diare berdarah yang parah; dan 2. Perawatan bedah dengan total kolektomi sudah dilakukan. 3. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis pencernaan/gastroenterologi berdasarkan temuan histopatologi.	berhubungan dengan distensi usus dan risiko pecahnya usus. Bukti medis harus mencakup semua hal berikut ini: a. Terdapat bukti biopsi yang membuktikan adanya <i>ulcerative colitis</i>; dan b. Terdapat bukti endoskopik bahwa kondisi ini mencakup seluruh usus besar; dan c. Terdapat persyaratan untuk terapi immunosupresi sistemik yang sedang berlangsung atau terapi immunomodulator untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan diawasi oleh seorang Dokter Spesialis pencernaan/gastroenterologi. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Mild Ulcerative Colitis</i>: a. Bentuk lain dari kolitis inflamasi; atau b. Kolitis ulserativa yang ada pada rektum.
75	<i>Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut</i> Peradangan akut dan nekrosis parenkim pankreas, nekrosis enzim fokal pankreas dan perdarahan karena nekrosis pembuluh darah. Kriteria di bawah ini harus terpenuhi: a. Tindakan yang diperlukan adalah pembedahan untuk membersihkan jaringan nekrotik atau pengangkatan pankreas; dan b. Diagnosis harus ditegakkan berdasarkan hasil histopatologi dan dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis <i>gastroenterology</i>. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari <i>Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut</i>: Penyalahgunaan alkohol, narkotika dan oba-obatan terlarang.	
		60 Penyakit atau Cedera pada Saraf Tulang Belakang yang Menyebabkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih Penyakit saraf tulang belakang atau cedera <i>chorda equina</i> mengakibatkan disfungsi usus permanen dan disfungsi kandung kemih yang membutuhkan kateterisasi secara teratur dan

			permanen atau saluran kemih permanen. Diagnosis harus didukung oleh seorang Dokter Spesialis saraf dan kondisi permanen dinilai dalam waktu 6 (enam) bulan.
76	Penyakit <i>Crohn</i> Akut (<i>Severe Crohn's disease</i>) Gangguan inflamasi transmural kronis pada usus. Untuk dianggap parah, harus ada bukti peradangan yang berlanjut meskipun telah diberikan terapi yang optimal, dengan semua hal berikut telah terjadi: 1. Pembentukan striktur yang menyebabkan obstruksi usus sehingga memerlukan rawat inap, dan 2. Pembentukan fistula di antara lengkung usus (Tidak termasuk Fistula-in-ano), dan 3. Setidaknya satu reseksi segmen usus yang disebabkan langsung oleh Penyakit <i>Crohn</i>. Diagnosis pasti harus ditegakkan oleh dokter spesialis gastroenterologi dan dibuktikan secara histologis pada laporan patologi dan/atau hasil sigmoidoskopi atau kolonoskopi	61	Penyakit <i>Crohn</i> Kronis Penyakit <i>Crohn</i> Kronis adalah penyakit radang/inflamasi usus granulomatosa kronis. Bukti medis harus mencakup semua ketentuan berikut ini: a. Diagnosis penyakit <i>crohn</i> harus ditegakkan oleh seorang Dokter Spesialis atas dasar endoskopi dan biopsi usus yang membuktikan diagnosis Penyakit <i>crohn</i>; dan b. Kondisi ini harus memerlukan perawatan immunosupresif terus menerus atau pengobatan terus menerus dengan obat imunomodulasi di bawah arahan Dokter Spesialis untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
77	Reseksi Seluruh Usus Halus (Duodenum, Jejunum, dan Ileum) Operasi pengangkatan seluruh usus halus termasuk duodenum, jejunum dan ileum sebagai akibat dari Penyakit atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Reseksi Seluruh Usus Halus (Duodenum, Jejunum, dan Ileum): Pengangkatan sebagian usus halus.		
78	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis (<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>) Diagnosis yang ditandai dengan lebih dari 3 (tiga) kali menderita radang kelenjar ludah perut, yang mengakibatkan penurunan fungsi kelenjar ludah perut dan membutuhkan pengobatan pengganti enzim. Diagnosis harus dibuat oleh Dokter Spesialis penyakit saluran pencernaan dan dipastikan oleh <i>Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography</i> (ERCP). Keadaan di bawah ini dikecualikan dari		

	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis (<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>): Radang kelenjar ludah perut kronis yang disebabkan mengonsumsi minuman mengandung alkohol.		
		62	Transplantasi Usus Kecil Transplantasi usus kecil yang diterima minimal sepanjang 1 (satu) meter dengan suplai darah sendiri melalui laparotomi akibat kegagalan usus.

K. Penyakit Kritis Lainnya

Penyakit Kritis Tahap Akhir		Penyakit Kritis Tahap Awal	
79	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>) Kegagalan fungsi sumsum tulang belakang yang kronik yang mengakibatkan anemia, neutropeni dan trombositopeni yang memerlukan pengobatan paling sedikit satu dari berikut ini: 1. Transfusi darah; 2. Obat stimulan sumsum tulang; 3. Obat imunosupresi; 4. Transplantasi sumsum tulang; 5. Diagnosis harus ditegakkan oleh Dokter Spesialis penyakit darah.	63	Sindrom Mielodisplastis atau Mielofibrosis Sindrom mielodisplastis atau <i>myelofibrosis</i> yang membutuhkan transfusi darah secara berkala dan permanen untuk anemia yang berulang dan parah. Diagnosis sindrom mielodisplastis (MDS) atau mielofibrosis harus dikonfirmasi oleh seorang Dokter Spesialis hematologi sebagai hasil dari biopsi sumsum tulang belakang. Kondisinya mesti dinilai tak dapat disembuhkan dan dukungan transfusi darah harus menjadi kebutuhan tak terbatas.
		64	Anemia Aplastik Reversibel Kegagalan pada sumsum tulang akut secara reversibel yang akan mengakibatkan anemia, neutropenia, dan trombositopenia. Diagnosis harus didasarkan pada biopsi sumsum tulang dan ditegakkan oleh Dokter Spesialis Penyakit darah (<i>haematologist</i>). Diagnosis anemia aplastik reversibel harus memenuhi 2 (dua) dari 3 (tiga) kriteria di bawah ini: 1. Jumlah neutrofil absolut 500 (lima ratus) per milimeter kubik atau kurang; 2. Jumlah retikulosit absolut 20.000 (dua puluh ribu) per milimeter kubik atau kurang; dan 3. Jumlah trombosit 20.000 (dua puluh ribu) per milimeter kubik atau kurang.

80	Adrenalektomi untuk Adenoma Adrenal Adrenalektomi yang dilakukan untuk pengobatan hipertensi sistemik yang tidak terkontrol dengan baik yang merupakan akibat sekunder dari <i>aldosteron</i> yang mensekresi adenoma adrenal dan tidak terkontrol oleh terapi medis. Adrenalektomi harus dianggap perlu untuk penanganan hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik oleh seorang Dokter Spesialis di bidang yang relevan.		
81	Hemofilia (Penyakit Darah) Parah Hemofilia yang diderita Tertanggung haruslah Hemofilia A yang berhubungan dengan pendarahan spontan dan dengan faktor pembekuan darah VIII atau Hemofilia B dengan faktor IX sejumlah kurang dari 1% (satu persen). Diagnosisnya harus dikonfirmasi oleh seorang Dokter Spesialis Terdaftar di bidang yang relevan. Keadaan di bawah ini dikecualikan dari hemofilia parah: Penyakit koagulasi selain hemofilia A (defisiensi VIII) atau hemofilia B (defisiensi IX).		
		65	Penolakan Transplantasi Organ Keadaan ketika jaringan yang ditransplantasi ditolak oleh sistem imun penerimanya setelah menjalani transplantasi organ sehingga jaringan yang ditransplantasi pun rusak. Klaim yang diajukan harus memenuhi seluruh ketentuan berikut: 1. Memburuknya fungsi organ yang ditransplantasikan meskipun sistem <i>imunosupresi</i> yang sesuai telah diterima; dan 2. Hilangnya fungsi organ transplantasi secara total dan tidak dapat dipulihkan kembali (<i>irreversible</i>); dan 3. Perawatan penunjang kehidupan (misalnya dialisis pada gagal ginjal) atau transplantasi organ kedua diperlukan untuk kelangsungan hidup; dan Diagnosis ini harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis yang relevan.

82	Terputusnya Akar-akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i> Kehilangan fungsi-fungsi sensorik secara menyeluruh dan permanen dari anggota gerak atas yang diakibatkan oleh terputusnya (<i>avulsi</i>) 2 (dua) atau lebih akar saraf dari <i>plexus brachialis</i> karena kecelakaan atau cedera. Cedera menyeluruh dari 2 (dua) atau lebih akar saraf ini harus dikonfirmasi dengan studi <i>Elektrodiagnostik</i> yang dilakukan oleh seorang Dokter rehabilitasi medik atau Dokter Spesialis saraf.		
83	Penyakit Stadium Akhir (<i>Terminal Illness</i>) Penyakit yang menurut diagnosis Dokter dan disetujui oleh Dokter yang ditunjuk Penanggung, akan menyebabkan kematian dalam waktu 6 (enam) bulan kemudian setelah diagnosis dibuat.		
84	Transplantasi Organ Tubuh Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>) Transplantasi sumsum tulang belakang menggunakan sel-sel pembentuk darah yang didahului oleh pengangkatan sumsum tulang belakang total atau transplantasi jantung, hati, paru-paru, pankreas atau ginjal. Transplantasi ini harus diperlukan secara klinis untuk mengobati kegagalan tahap akhir yang menetap (<i>irreversible</i>) dari organ yang bersangkutan. Keadaan-keadaan di bawah ini dikecualikan dari transplantasi organ tubuh utama: 1. Transplantasi sel-sel pembentuk lainnya; atau 2. Transplantasi sekelompok sel atau jaringan; atau 3. Transplantasi suatu bagian organ.		
85	Transplantasi Sumsum Tulang Belakang Diterimanya transplantasi sumsum tulang manusia menggunakan sel induk <i>hematopoietic</i> didahului dengan ablasi sumsum tulang total. Transplantasi sel induk lainnya dikecualikan.		